

FACULTE DE MEDECINE DE SOUSSE

CONCOURS DE RESIDANAT 2025

LES INFECTIONS URINAIRES

(Evaluation)

Pr Foued Bellazreg

QCM

1. Concernant l'infection urinaire (IU) :

- A- les urines sont normalement stériles
- B- le méat urétral peut être colonisé par des bactéries d'origine digestive
- C- la contamination du rein se fait le plus souvent par voie ascendante
- D- la pyélonéphrite précède la cystite
- E- *Enterobacter* est la bactérie le plus fréquemment isolée dans les IU

2. Les moyens de défense contre la survenue d'une infection urinaire sont :

- A- longueur de l'urètre
- B- osmolarité urinaire faible
- C- pH urinaire acide
- D- protéine de Tamm-Horsfall
- E- rétention des mictions

3. Les bactéries les plus fréquemment responsables d'infections urinaires communautaires sont :

- A- *Acinetobacter baumannii*
- B- *Enterobacter cloacae*
- C- *Escherichia coli*
- D- *Klebsiella pneumoniae*
- E- *Pseudomonas aeruginosa*

4. En Tunisie, le taux de résistance d'*Escherichia coli* à la ciprofloxacine en 2022 était d'environ :

- A- 10%
- B- 20%
- C- 30%
- D- 40%
- E- 50%

5. En Tunisie, le taux de résistance d'*Escherichia coli* au céfotaxime en 2022 était d'environ :

- A- 5%
- B- 15%
- C- 25%
- D- 35%
- E- 45%

6. En Tunisie, le taux de résistance d'*Escherichia coli* à l'imipénème en 2022 était d'environ :

- A- 0%
- B- 5%
- C- 10%
- D- 15%
- E- 20%

7. Les antibiotiques suivants peuvent être utilisés en 1^{ère} intention pour le traitement des IU communautaires de l'adulte :

- A- amoxicilline - acide clavulanique
- B- fosfomycine
- C- gentamicine
- D- imipénème
- E- triméthoprim - sulfaméthoxazole

8. Les facteurs suivants favorisent la survenue d'une infection urinaire chez l'adulte :

- A- grossesse
- B- mictions fréquentes
- C- hypertrophie de la prostate
- D- rétrécissement urétral
- E- vidange incomplète de la vessie

9. La cystite récidivante est définie par la survenue de :

- A- 2 épisodes de cystite par an
- B- 3 épisodes de cystite par an
- C- 4 épisodes de cystite par an
- D- 2 épisodes de cystite par semestre
- E- 3 épisodes de cystite par semestre

10. Une infection urinaire est dite à risque de complication dans les situations suivantes :

- A- acte urologique récent
- B- lithiase urinaire
- C- insuffisance rénale chronique modérée
- D- sexe féminin
- E- tumeur urothéliale

11. La pyélonéphrite aiguë emphysémateuse :

- A- survient souvent chez le diabétique
- B- est caractérisée par la présence de gaz dans le parenchyme rénal
- C- est due le plus souvent à *Escherichia coli*
- D- nécessite un traitement médico-chirurgical
- E- est de mauvais pronostic

12. Sont considérées infections urinaires graves :

- A- l'abcès du rein
- B- la cystite hémorragique
- C- la cystite récidivante
- D- le phlegmon périnéphrétique
- E- la pyonéphrose

13. Chez la femme enceinte, l'infection urinaire est favorisée par les facteurs suivants :

- A- ascension du trigone vésical
- B- compression de l'uretère droit par l'utérus
- C- diminution de la concentration du glucose dans les urines
- D- hypertonie urétérale
- E- reflux vésico-urétéral

14. Les bactéries suivantes réduisent les nitrates en nitrites :

- A- *Acinetobacter baumannii*
- B- *Escherichia coli*
- C- *Klebsiella pneumoniae*
- D- *Pseudomonas aeruginosa*
- E- *Staphylococcus saprophyticus*

15. Une bandelette urinaire sans ECBU peut suffire dans la prise en charge d'un(e) patient(e) ayant :

- A- un abcès du rein
- B- une cystite simple
- C- un phlegmon périnéphrétique
- D- une prostatite aiguë
- E- une pyélonéphrite aiguë

16. Les conditions suivantes doivent être respectées lors de la réalisation d'un ECBU :

- A- désinfection périnéale
- B- lavage des mains
- C- ne pas toucher le bord supérieur du flacon
- D- recueil dans un flacon propre
- E- recueil des urines du premier jet

17. L'examen de référence pour l'étude du parenchyme rénal est :

- A- l'échographie
- B- l'IRM
- C- la TDM
- D- l'urographie intraveineuse
- E- la scintigraphie

18. Une échographie de l'appareil urinaire doit être réalisée chez tout(e) patient(e) ayant :

- A- cystite simple
- B- cystite récidivante
- C- pyélonéphrite aiguë à risque de complication
- D- prostatite aiguë
- E- pyélonéphrite aiguë grave

19. La leucocyturie est définie par la présence de leucocytes dans les urines à un taux supérieur ou égal à :

- A- 10/ml
- B- 100/ ml
- C- 1000/ ml
- D- 10000/ ml
- E- 100000/ ml

20. Le seuil de bactériurie significative pour *Escherichia coli* est de :

- A- 10/ml
- B- 100/ ml
- C- 1000/ ml
- D- 10000/ ml
- E- 100000/ ml

21. Les causes possibles d'une leucocyturie sans germe sont :

- A- antibiothérapie préalable
- B- lithiase urinaire
- C- pyélonéphrite aigue
- D- tuberculose urogénitale
- E- tumeur urothéliale

22. La pyonéphrose :

- A- complique souvent un reflux vésico-urétéral
- B- est traité par antibiothérapie et drainage percutané
- C- est une rétention purulente d'urines
- D- se complique de sepsis
- E- se manifeste par un contact lombaire indolore

23. Les antibiotiques à utiliser en 1^{ère} intention pour le traitement d'une cystite aigue simple sont :

- A- amoxicilline
- B- céfixime
- C- ciprofloxacine
- D- fosfomycine
- E- nitrofurantoïne

24. Les mesures hygiéno-diététiques préconisées chez les patients ayant une cystite récidivante sont :

- A- restriction hydrique
- B- excès d'hygiène intime
- C- régularisation du transit intestinal
- D- non rétention des mictions
- E- utilisation de spermicides

25. Les critères d'hospitalisation d'un patient ayant une pyélonéphrite aigue sont :

- A- pyélonéphrite à risque de complication
- B- doute diagnostique
- C- doute sur l'observance au traitement
- D- impériosité mictionnelle
- E- pyélonéphrite hyperalgique

26. Parmi les antibiotiques suivants, lequel est le moins pourvoyeur d'allergie :

- A- amoxicilline
- B- céfixime
- C- cotrimoxazole
- D- imipénème
- E- gentamicine

27. Parmi les antibiotiques suivants, lequel est le plus pourvoyeur de néphrotoxicité:

- A- amoxicilline
- B- céfixime
- C- céfotaxime
- D- ciprofloxacine
- E- gentamicine

28. La tendinopathie est une complication classique de l'antibiotique suivant :

- A- céfixime
- B- ciprofloxacine
- C- lévofloxacine
- D- ofloxacine
- E- pipéracilline - tazobactam

Cas cliniques

Cas clinique 1 :

Une patiente âgée de 60 ans, sans antécédents pathologiques, consulte pour brûlures mictionnelles avec pollakiurie évoluant depuis une semaine sans fièvre ni douleur lombaire. Examen physique : normal.

1- Quel est le premier diagnostic à évoquer chez cette patiente :

- A- cystite aiguë à risque de complication
- B- cystite aiguë simple
- C- lithiase urinaire
- D- pyélonéphrite aiguë simple
- E- vulvo-vaginite

2- Quel est l'examen à réaliser en 1^{ère} intention :

- A- AUSP
- B- ECBU
- C- bandelette urinaire
- D- échographie de l'appareil urinaire
- E- échographie pelvienne

3- Quelle antibiothérapie de 1^{ère} intention prescrivez-vous ?

- A- amoxicilline - acide clavulanique
- B- céfixime
- C- ciprofloxacine
- D- cotrimoxazole
- E- fosfomycine

4- Quelle est la durée du traitement prescrit :

- A- 1 jour
- B- 3 jours
- C- 5 jours
- D- 7 jours
- E- 10 jours

Cas clinique 2 :

Une patiente âgée de 30 ans, sans antécédents pathologiques, enceinte à 10 semaines d'aménorrhée, consulte pour brûlures mictionnelles, fièvre et douleur lombaire gauche évoluant depuis 48 heures. Examen physique : T°39°, FC 100/min, TA 12/7 ; douleur à la palpation de la fosse lombaire gauche.

Vous suspectez une pyélonéphrite aiguë.

1- Quels examens complémentaires demandez-vous ?

- A- AUSP
- B- ECBU
- C- échographie de l'appareil urinaire
- D- échographie obstétricale
- E- hémocultures

2- Quelle antibiothérapie prescrivez-vous ?

- A- céfixime
- B- amoxicilline - acide clavulanique
- C- ciprofloxacine
- D- céfotaxime
- E- gentamicine

L'évolution clinique était favorable. L'ECBU est revenu positif à *Escherichia coli* de phénotype sauvage.

3- Quelle antibiothérapie de relais de 1^{ère} intention prescrivez-vous ?

- A- amoxicilline
- B- amoxicilline - acide clavulanique
- C- céfixime
- D- ceftriaxone
- E- cotrimoxazole

4- Quelle est la durée totale de l'antibiothérapie :

- A- 5 jours
- B- 7 jours
- C- 10 jours
- D- 21 jours
- E- 28jours

5- Après la guérison de la pyélonéphrite aigue chez cette patiente, un ECBU de contrôle :

- A- n'est pas nécessaire en l'absence de signes d'infection urinaire
- B- doit être réalisé pour dépister une bactériurie asymptomatique
- C- doit être réalisé 10 jours après l'accouchement
- D- doit être réalisé tous les 15 jours jusqu'à l'accouchement
- E- doit être réalisé tous les mois jusqu'à l'accouchement

Cas clinique 3 :

Un patient âgé de 40 ans, sans antécédents pathologiques, consulte pour douleur lombaire droite paroxystique irradiant vers les organes génitaux externes avec fièvre à 39° évoluant depuis 24 heures. Examen (dont un toucher rectal) : normal en dehors de la fièvre et de la douleur lombaire.

1- Quel diagnostic évoquez-vous en premier ?

- A- appendicite rétrocoecale
- B- pyélonéphrite aigue simple
- C- pyélonéphrite aigue sur lithiase
- D- prostatite aigue
- E- tumeur urétérale

2- Quels examens complémentaires demandez-vous ?

- A- créatinine
- B- ECBU
- C- échographie de l'appareil urinaire
- D- hémocultures
- E- scintigraphie rénale

3- Les antibiotiques à prescrire en 1^{ère} intention sont ?

- A- amikacine
- B- ciprofloxacine
- C- céfotaxime
- D- cotrimoxazole
- E- imipénème

Un traitement ambulatoire par ciprofloxacine a été prescrit. 48 heures après, le patient a été amené par sa famille pour persistance des douleurs lombaires, devenus plus intenses et continues, et de la fièvre. Examen : TA 8/4, FC 130 /min, extrémités froides, GSG 13/15, contact lombaire douloureux. Un remplissage vasculaire adéquat a été effectué avec persistance d'une hypotension à 80/40 mm ayant nécessité le recours à la noradrénaline IV. Hg. Créatinine 70 μ mol/L.

4- Quels diagnostics évoquez-vous ?

- A- abcès du rein
- B- colique néphrétique
- C- phlegmon périnéphrétique
- D- pyélonéphrite emphysémateuse
- E- pyonéphrose

5- Quelle antibiothérapie de 1^{ère} intention prescrivez-vous ?

- A- céfotaxime + ciprofloxacine
- B- céfotaxime + gentamicine
- C- imipénème + amikacine
- D- pipéracilline-tazobactam + ciprofloxacine
- E- pipéracilline-tazobactam + gentamicine

6- Quelles autres mesures thérapeutiques sont nécessaires ?

- A- dexaméthasone
- B- drainage percutané ou chirurgical
- C- ibuprofène
- D- paracétamol
- E- antispasmodique

Après traitement, l'état hémodynamique du patient s'est stabilisé.

7- Quel est le meilleur examen d'imagerie à demander ?

- A- AUSP
- B- échographie de l'appareil urinaire
- C- IRM
- D- scintigraphie
- E- uroscan

L'évolution était favorable.

8- Quelle est la durée totale de l'antibiothérapie ?

A- 5 jours

B- 7 jours

C- 10 jours

D- 21 jours

E- 30 jours